DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM RAG: QUY TRÌNH BỆNH VIỆN

Bản tổng hợp quy trình phổ thông và an toàn người bệnh, tham khảo WHO High 5s. Dùng để kiểm thử retrieval, không phải quy trình chính thức của một bệnh viện cụ thể.

Phạm vi và cảnh báo

Tài liệu này kết hợp (1) luồng phục vụ người bệnh phổ thông ở mức khái quát và (2) một số quy trình an toàn chuyên môn được WHO mô tả, như đối soát thuốc khi chuyển tiếp chăm sóc và xác nhận đúng vị trí phẫu thuật. Luồng đăng ký/khám/nhập viện/xuất viện dưới đây chỉ là mô hình minh họa; quy trình thực tế, biểu mẫu, quyền hạn và thời gian xử lý phụ thuộc từng bệnh viện và quy định tại địa phương.

Luồng tổng quát của người bệnh

1. Tiếp nhận và đăng ký

Người bệnh liên hệ quầy tiếp nhận hoặc hệ thống đăng ký; cung cấp thông tin định danh và thông tin hành chính cần thiết. Nhân viên kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn nơi khám và xác nhận thông tin bảo hiểm/chi phí theo quy định của cơ sở.

Lưu ý: Dữ liệu cần quản lý: mã lượt khám, thời gian, khoa/phòng, trạng thái hồ sơ. Không đưa dữ liệu định danh thật vào bộ dữ liệu thử nghiệm.

2. Sàng lọc / phân loại mức độ ưu tiên

Nhân viên y tế đánh giá ban đầu theo quy trình của cơ sở để nhận biết người bệnh cần được xử trí khẩn cấp. Phân loại ưu tiên không thay thế chẩn đoán và chỉ do người được đào tạo thực hiện.

Lưu ý: Nếu có dấu hiệu đe dọa tính mạng, người bệnh cần được chuyển ngay tới quy trình cấp cứu của cơ sở thay vì chờ theo thứ tự đăng ký thông thường.

3. Khám lâm sàng

Nhân viên y tế hỏi bệnh sử, triệu chứng, thời điểm khởi phát, thuốc đang sử dụng, dị ứng và tiền sử liên quan; khám và quyết định bước đánh giá tiếp theo theo chuyên môn.

Lưu ý: Chatbot có thể giải thích quy trình chung nhưng không được thay thế việc khám, phân loại cấp cứu hoặc quyết định của nhân viên y tế.

4. Xét nghiệm / chẩn đoán hình ảnh khi được chỉ định

Nếu có chỉ định, người bệnh được hướng dẫn chuẩn bị, thực hiện xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh và nhận kết quả theo quy trình của cơ sở. Kết quả cần được nhân viên có thẩm quyền diễn giải trong bối cảnh lâm sàng.

Lưu ý: Không tự diễn giải một chỉ số riêng lẻ thành chẩn đoán. Cần kiểm tra đúng người bệnh, đúng mẫu và đúng thông tin yêu cầu.

5. Quyết định hướng xử trí

Dựa trên đánh giá tổng thể, nhân viên y tế trao đổi kế hoạch: điều trị ngoại trú, theo dõi, chuyển khoa, nhập viện hoặc chuyển đến cơ sở khác nếu cần.

Lưu ý: Hướng xử trí cụ thể phụ thuộc tình trạng người bệnh, nguồn lực và quy định chuyên môn của bệnh viện.

6. Nhập viện và chuyển giao chăm sóc

Khi nhập viện, cơ sở hoàn thiện hồ sơ, xác nhận khoa/phòng tiếp nhận, bàn giao các thông tin cần thiết và lập kế hoạch chăm sóc. Khi chuyển khoa hoặc chuyển cơ sở, thông tin lâm sàng, thuốc, dị ứng, kết quả và

các việc đang chờ cần được truyền đạt rõ ràng.

Lưu ý: Bàn giao có cấu trúc giúp giảm bỏ sót thông tin. Quy trình chính thức cần tuân thủ quy định của bệnh viện.

7. An toàn thuốc và đối soát thuốc

WHO High 5s mô tả quy trình đối soát thuốc nhằm bảo đảm thông tin thuốc chính xác khi người bệnh chuyển tiếp giữa các giai đoạn chăm sóc. Về khái quát, nhóm chăm sóc thu thập danh sách thuốc đang dùng, đối chiếu với y lệnh hiện tại, làm rõ khác biệt và ghi nhận/cập nhật thông tin theo trách nhiệm chuyên môn.

Lưu ý: Đây là quy trình dành cho nhân viên y tế được đào tạo; không tự ý dùng tài liệu này để kê đơn, thay đổi liều hoặc ngừng thuốc.

8. An toàn trước phẫu thuật / thủ thuật

Các quy trình an toàn phẫu thuật nhấn mạnh việc xác minh người bệnh, thủ thuật và vị trí cần can thiệp; kiểm tra hồ sơ, sự đồng thuận và các điểm an toàn theo checklist của cơ sở trước khi tiến hành.

Lưu ý: Chi tiết checklist phải theo quy trình chính thức, hướng dẫn chuyên môn hiện hành và phân công trách nhiệm của cơ sở.

9. Xuất viện và hướng dẫn sau điều trị

Khi có quyết định xuất viện, nhóm chăm sóc chuẩn bị tóm tắt điều trị, hướng dẫn thuốc theo đơn, lịch tái khám, dấu hiệu cần quay lại viện và cách liên hệ khi có vấn đề. Thông tin cần được giải thích dễ hiểu và xác nhận người bệnh/người chăm sóc đã nắm được.

Lưu ý: Nếu triệu chứng nặng lên hoặc xuất hiện dấu hiệu cấp cứu, cần tìm trợ giúp y tế khẩn cấp thay vì chờ chatbot.

Các câu hỏi thử nghiệm RAG

- Người bệnh thường trải qua những bước nào khi đến khám ngoại trú?
- Vì sao cần sàng lọc mức độ ưu tiên ngay từ đầu?
- Khi chuyển khoa, những nhóm thông tin nào cần được bàn giao?
- Đối soát thuốc là gì và mục tiêu chính là gì?
- Những yếu tố nào cần được xác minh trước phẫu thuật?
- Hướng dẫn xuất viện nên bao gồm những nội dung nào?

Metadata gợi ý

category=hospital_procedures; topic=tên quy trình; source_org=WHO hoặc bản mô hình minh họa; source_url=URL nguồn; language=vi-summary; document_type=educational-summary; jurisdiction=general; review_status=needs_local_policy_review.

Nguồn tham khảo chính thức

1. WHO High 5s: Standard Operating Procedures
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/high-5s-standard-operating-procedures

2. WHO High 5s Standard Operating Protocol: Medication Reconciliation
https://www.who.int/publications/m/item/high5s-standard-operating-protocol-medication-reconciliation

3. WHO High 5s Implementation Guide: Medication Reconciliation
https://www.who.int/publications/m/item/high5s-implementation-guide-medication-reconciliation

4. WHO Patient Safety Guidance and Tools
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/quality-of-care-and-patient-safety/patient-safety-guidance-and-tools

Giới hạn sử dụng

WHO High 5s là tài liệu về các quy trình an toàn người bệnh, không phải sổ tay đầy đủ về hành chính bệnh viện Việt Nam. Phần luồng khám–nhập viện–xuất viện trong file được viết ở mức

khái quát để tạo câu hỏi thử nghiệm, không được trình bày như quy trình chính thức của bất kỳ bệnh viện nào. Trước khi dùng trên website thật, hãy thay bằng tài liệu đã được bệnh viện xác nhận và được người có chuyên môn rà soát.